

MALTRATO HACIA NIÑOS NIÑAS Y /O ADOLESCENTES

Bibliográfica Hospital Perrupato - Dr. Navarro David - 2025

1. Sospecha de maltrato físico infantil: CIE 10 T76.12
2. Sospecha de maltrato psicológico infantil: CIE 10 T76.32
3. Sospecha de abuso sexual : CIE 10 T76.22
4. Sospecha negligencia – abandono infantil: CIE 10 T76.02
5. Maltrato físico infantil: CIE 10 T74.12
6. Maltrato psicológico infantil: CIE 10 T74.32
7. Abuso sexual infantil: CIE 10 T74.22
8. Negligencia – abandono infantil: CIE 10 T74.02
9. S° de Muchenhausen: CIE 10 F68.1
10. Trastornos mentales y comportamiento por consumo de sustancias: CIE 10 F10 – F19
11. HIV: CIE 10 B24
12. Intento de suicidio, riesgo de suicidio o historia personal de autolesión: CIE 10 Z91.5

Generalidades

La valoración de la gravedad de un maltrato se puede definir por:

1. La cercanía afectiva/familiar/ambiental del agresor/a que ha provocado el Maltrato.
2. El tipo de lesiones y secuelas del maltrato en el niño/a.
3. Si se trata de un hecho aislado o de una situación repetida.
4. La posibilidad de autoprotección del propio niño/a o lo que es lo mismo, la existencia de factores de vulnerabilidad tales como:
 - La corta edad del niño/a.
 - Las limitaciones personales (discapacidad física y/o psíquica).
5. La inexistencia de factores protectores externos: - Inexistencia de adultos cercanos que puedan proteger sus derechos o que tengan capacidades para ello.

Para que una situación se considere URGENTE se deben dar los siguientes criterios:- Que la salud o seguridad básicas del niño se encuentren seria y directamente amenazadas como consecuencia de la acción u omisión de los padres o cuidadores y/o- Que no exista una figura familiar o de apego que pueda hacerse cargo.

1. Abuso físico

Cualquier acción no accidental por parte de los padres o cuidadores que provoque daño físico o enfermedad en el niño o lo coloque en grave riesgo de padecerlo.

Se manifiesta por:

- Versión contradictoria entre el relato de los padres y las lesiones que presenta el niño.
- Retraso en la búsqueda de asistencia médica.
- Lesiones en la piel en diferente estadio evolutivo.
- Hematomas y contusiones localizadas en zonasno prominentes.
- Mordeduras, alopecia traumática, lesiones enmucosa bucal (quemaduras, hematomas, pérdidao fracturas de dientes).
- Quemaduras en periné, genitales, nalgas o extremidades(simétricas o en espejo) y en cualquierubicación cuando sean de cigarrillo.
- Lesiones óseas en diferente estadio evolutivo, fracturas diafisarias en “espiral”, fracturas metafisarias en “asa de cubeta”, despegamiento perióstico por hemorragia subperióstica, fractura de cráneo asociada o no a hematoma subdural; fractura múltiple de costillas, adyacentes, en general en la región posterolateral.
- Asociación de lesiones cutáneas, óseas, oculareso viscerales.
- Lesiones oculares: hemorragias retinianas unilateraleso bilaterales, desprendimiento de retina, hemorragia vítrea, cataratas traumáticas, etc.
- Asociación de fracturas de huesos largos con hematoma subdural.

- Recidiva de patología lesional y asistida en distintos centros asistenciales.
- Merece una mención el síndrome del **bebé sacudido (shaking baby)** que se presenta generalmente en lactantes con edema cerebral, hemorragia retiniana y hematoma subdural.

Anamnesis

- Descripción del hecho
- Cómo se produjeron las lesiones
- Dónde se produjeron
- Quienes estaban con el niño, día y hora del episodio traumático
- Día y hora en que lo trajeron al hospital
- Si existen acusaciones
- Variaciones en la narración
- Discrepancias entre la historia clínica y las lesiones

Antecedentes personales:

- Consignar circunstancias de la familia y pareja en las que acaece.
- Antecedentes de abortos previos.
- Depresión por el embarazo.
- Preocupación por el sexo del bebé.
- Reacción frente al nacimiento.
- Niño prematuro.
- Niño malformado o discapacitado.
- Niño llorón, difícil o rebelde.
- **En los padres es importante indagar estos antecedentes:**
 - Golpeados o carentes de afecto en la niñez.
 - Maltrato físico o sexual.
 - Portador de enfermedad mental.
 - Alcohólico o drogadicto.
 - Antecedentes médicos de la familia.
 - Aislamiento.
- **Antecedentes socio ambientales:**
 - Tipo de unión de pareja parental.
 - Grupo conviviente con el niño.
 - Situación laboral de los adultos.
 - Ingreso mensual.
 - Características de la vivienda.
 - Relación entre los padres (tipo de comunicación).
 - Causas para la agresión.
 - Quién toma el mayor número de decisiones acerca de los hijos.
 - Cómo es un día de rutina en el ámbito familiar en el cual participa el niño.

Solicitar en todos los casos Rx de cráneo y huesos largos para detectar fracturas previas consolidadas.

2. Maltrato psicológico

Abandono emocional

Falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisas), expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el niño, y falta de iniciativa de interacción y contacto por parte de alguna figura adulta estable.

El abandono emocional comparte las características de la sintomatología vinculada al maltrato emocional y habitualmente acompaña al maltrato por negligencia o abandono físico.

Maltrato emocional

Hostilidad verbal crónica en forma de insulto, burla, desprecio, crítica y amenaza de abandono y constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro) por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar.

Se manifiesta por:

- Problemas conductuales.
- Sintomatología psicosomática y emocional.
- Trastornos del desarrollo.
- Déficit del rendimiento escolar.

3. Negligencia – abandono

Aquella situación en que las necesidades físicas básicas del menor (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en situaciones potencialmente peligrosas o cuidados médicos) no son atendidos temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con el niño.

Se sospecha en los siguientes casos:

- Niño mal vestido
- Falta de higiene
- Palidez
- Tristeza, apatía
- Talla y peso por debajo del tercer percentil, por déficit nutricional o caída del percentil
- Falta de interacción madre-hijo
- Desarrollo no acorde con la edad cronológica
- Mejoría manifiesta y rápida durante su internación

4. Maltrato institucional

Cualquier Legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los Poderes Públicos, Organismos Gubernamentales (JUSTICIA, EDUCACIÓN, SALUD, SERVICIOS SOCIALES) y No Gubernamentales o bien derivada de la actuación individual del profesional actuante que comporten abusos, negligencias, detrimento de la salud, de la seguridad, del estado emocional, del bienestar físico, de la correcta maduración o que violen los derechos básicos del niño emanados de cualquier jurisdicción conforme al marco legal vigente.

La denuncia de este tipo de maltrato se realiza por escrito con todos los datos del denunciante derivándolo al Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia y, paralelamente a la Institución competente en el caso.

5. S° de Muchenhausen

Simulación por parte del padre, madre o tutor de síntomas físicos patológicos, mediante la administración de sustancias o manipulación de excreciones o sugerencia de sintomatologías difíciles de demostrar que conducen a internaciones o estudios complementarios innecesarios.

Síntomas referidos por el progenitor que no admiten explicación (hemorragias, síntomas neurológicos, hipertermia, alteraciones en exámenes complementarios).

Recurrencia inexplicable de enfermedades.

Los supuestos síntomas o signos no se evidencian en ausencia de la madre o el padre.

Las manifestaciones clínicas no se condicen con la historia del paciente.
Madre o padre excesivamente “atento” que no admite separarse del hijo supuestamente enfermo.
Se presentan a veces cuadros neurológicos graves de difícil explicación y de evolución no habitual.

6. Abuso sexual

Comprende los actos con un contenido sexual manifiesto en los que están involucrados niños o adolescentes

Se incorporan:

- Exposición a videos o películas pornográficas, material gráfico o internet
- Exhibicionismo
- Voyerismo (excitación sexual observando, sin que sea visto, a otras personas que se desvisten o están desnudas o bien haciendo algún acto sexual)
- Tocamientos y estimulación de los genitales o el orificio anal
- Masturbación del ofensor o la víctima
- Sexo oral
- Penetración genital y/o anal

“La mayoría de los abusos sexuales infantojuveniles son efectuados por algún miembro de la familia, no hay uso de fuerza física para desarrollarlo, se mantiene en secreto y se va desarrollando en el tiempo.”

Manifestaciones psicológicas del abuso

Lactantes

- Irritabilidad y llanto injustificado

Primera infancia

- Masturbación compulsiva.
- Juegos sexuales inapropiados para la edad del niño.
- Trastornos del sueño (pesadillas, terrores nocturnos).
- Miedos intensos (para ir a la cama, acercarse o permanecer con ciertas personas).
- Cambios notorios en los hábitos alimentarios (por exceso o restricción en la ingesta).
- Crisis de llanto sin explicación.

Edad escolar

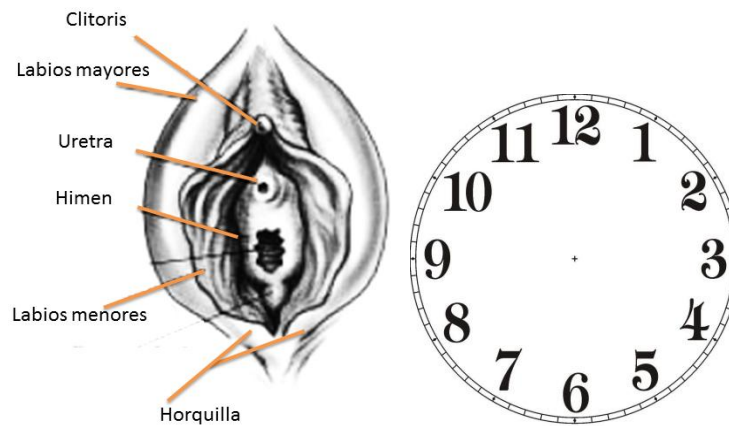
- Trastornos del aprendizaje.
- Dificultades en la integración al grupo de pares.
- Cefaleas y/o dolores abdominales que no corresponden a causa orgánica.
- Fobias escolares.
- Miedos.
- Enuresis y/o encopresis secundaria.
- Dificultades en aceptar compartir un vestuario con sus pares por temor a ser visto sin ropa.
- Conductas hipersexualizadas. Masturbación compulsiva que se desarrolla en cualquier lugar
- Observación del cuerpo de los demás, imposición a otro por la fuerza y sin consentimiento, tocamientos, movimientos coitales.

Adolescencia

- Cefaleas y/o dolores abdominales que no corresponden a causa orgánica.
- Patología alimentaria manifiesta como anorexia o bulimia.
- Fugas del hogar.
- Consumo de alcohol o drogas.
- Manifestaciones auto agresivas de distinto tipo.
- Intentos de suicidio.
- Comportamientos sexuales promiscuos.
- Conductas antisociales.
- Mal rendimiento escolar / deserción escolar.

Lesiones posiblemente asociadas al abuso sexual

Anatomía



(Describir hora de cada lesión anal o vaginal)

Genitales femeninos:

- Cualquier lesión encontrada en niños con abuso documentado
- Trauma agudo, con sospecha de abuso sexual:
 - Laceración aguda o abrasión en labios, horquilla o tejido perianal
 - Laceraciones o mordidas en los genitales o región cercana
 - Lesiones de succión en los genitales o regiones cercanas
- Cicatrices asociadas con posible abuso:
 - Cicatriz en la horquilla
 - Escotaduras que se extienden más de un 50% en el anillo himeneal posterior (inferior) o lateral.
- Ano:
 - Laceración o edema de la piel perianal
 - Cicatriz perianal (puede darse por patología como enfermedad de Crohn)

Genitales Masculinos:

- Pene/escroto: Ataduras del pene con el pelo del niño/a u otro objeto; mordeduras o punciones; lesión por succión en el pene, escroto o región cercana a los genitales.

Evidencia clara de abuso sexual

Genitales femeninos:

- Lesiones en himen o vagina que no tienen otra explicación
- Completa o parcial laceración del himen
- Equimosis en himen
- Laceración vaginal
- Lesión anterior curada:
 - Desgarro antiguo de himen, con ausencia de tejido himeneal

Ano:

- Laceraciones perianales que se extienden en forma profunda en el esfínter anal

Otras evidencias de abuso sexual:

Embarazo

- Hallazgo de espermatozoides en el cuerpo de la víctima
- Videos o fotografías que documentan el abuso
- Cultivos positivos: anales, orales o vaginales de *Neisseria gonorrhea*; cultivo de *Chlamydia trachomatis* de la región anal o genital
- Serología positiva para HIV, sífilis

Enfermedades de transmisión sexual

Trichomonas:

A veces se transmite durante el nacimiento y en general se resuelve espontáneamente al disminuir la concentración de estrógenos. A pesar de ser factible su transmisión por otros medios (toallas, elementos húmedos), mayoritariamente es por vía sexual

N. gonorrhoeae:

En la niña pre púber produce un cuadro de vulvovaginitis con abundante secreción purulenta verdosa e intenso prurito

Chlamydia trachomatis:

Puede ser transmitida a los lactantes por sus madres, pero en ninguno de los casos estudiados y controlados persistió el cultivo positivo a los dos años de vida

Herpes Simple

- Tipo 1 o labiobucal: puede producir vulvovaginitis por autoinoculación
- Tipo 2 o genital se puede adquirir por contacto sexual.
- El más frecuente en estos casos es el Herpes tipo 2, con el mismo serotipo en adolescentes jóvenes sexualmente activos.
- Produce una vesícula muy dolorosa y ulcerada que toma piel y mucosas y se puede acompañar de fiebre

HPV

- Las infecciones del papilomavirus se pueden transmitir por el canal del parto y por pasaje placentario, manifestándose clínicamente hasta tres años después.
- La forma clínica de presentación es condiloma acuminado

Sífilis

- Primaria o chancro primario: es una lesión ulcerada, limpia de bordes sobre elevados e indolora, que aparece en el sitio de la primo infección y según su ubicación se las puede confundir con fisuras anales o un cuadro de celulitis perianal.
- Forma secundaria se presenta como un rash macular y eritematoso (roséola), que aparece primero en la parte superior del tronco y proximal de extremidades superiores, para luego generalizarse.
Se la puede confundir con un exantema viral, siendo clásicos el rash en palmas y plantas de los pies.

Examen genital

- **Urgente:**
 - Agresión reciente (menos de 72 hs), donde existe posibilidad de tomar muestras para analizar y evitar su pérdida (manchas, pelos, ropas), siendo aconsejable realizarlas en el ámbito forense para un mejor estudio y resguardo adecuado.
 - Necesidad de tratamiento médico o quirúrgico de urgencia, por las lesiones que presente.
- **No urgentes**
 - También debe realizarse el examen físico y ginecológico, pero en tiempo y forma y con la preparación adecuada y el consentimiento del niño, ya que de no ser así, el examen resultaría revictimizante.
- Debemos reparar en las diferentes variantes anatómicas normales del himen (puntiforme, anular, denticular, semilunar) y describir la presencia o no de la membrana, además de consignar, si hubiera, desgarros, muescas, cicatrices, a los cuales se los denomina siguiendo las horas de un reloj, etc.
- Las lesiones ubicadas en la mitad inferior del himen entre las horas 4 y 8 en posición genupectoral son habitualmente traumáticas y sugestivas de abuso sexual.

- Al finalizar el examen físico es importante hablar con la niña o la adolescente y con el adulto de su confianza, explicando los hallazgos encontrados en el curso del mismo y su significación futura.
- Se procurará tranquilizarlos, ya que muchos asumen que la paciente “está lesionada para siempre”.
- Si existen lesiones, se debe explicar el tratamiento y el seguimiento.
- Cuando el traumatismo es mínimo, explicar que cicatriza sin secuelas visibles.

Laboratorio de emergencia

Ideal antes del inicio del tratamiento o profilaxis

- Hemograma completo
- Si comienza kits de emergencia o se cree que quizás lo comience:
 - GOT, GPT, FAL, BT y Fraccionada
 - Uremia y creatinemia
- VDRL
- Si la niña ha alcanzado la menarca: Sub unidad β
- Orina completa (indicar búsqueda de espermatozoides)

Serología:

- HIV (con registro y firma del consentimiento informado), inicial y al mes.
- Hepatitis B, C y D, inicial y al mes.

Cultivos en caso de secreción vaginal:

- Gonorrea inicial y a las tres semanas

En caso de presentar secreciones se tomarán muestras de endocervix en víctimas sexualmente activas y de exocervix cuando no ha iniciado relaciones sexuales.

Se pueden además tomar muestras de uretra, ano y faringe.

- Chlamydia, inicial y a las tres semanas

La toma de las muestras se recogerá de orina, vagina y exocervix endocervix (víctimas sexualmente activas).

- Trichomonas

Se solicitará mediante hisopado de uretra, vagina y ano

- Sífilis, inicial y a las seis semanas

Si VDRL es (+)

Dilución 1/8: sospechoso, hay que repetir muestra y 1/16 en adelante se considera positiva, por lo cual, debe iniciar tratamiento, previamente solicitar:

- Estudio directo con microscopio de fondo oscuro
- En sangre, FTA-Abs (da positiva incluso las parcialmente tratadas)

Otros:

Búsqueda de elementos no vitales (manchas, pelos), siempre que exista intervención judicial, y a solicitud de ésta, se deben guardar los elementos pequeños en tubo seco (de ser posible), y guardar las ropas debidamente rotuladas en sobre de papel madera cuando la prenda esté seca.

Conducta

Profilaxis antitetánica

Si la vacunación es incompleta o han pasado más de 10 años de la última dosis.

Tratamiento profiláctico antirretroviral

Si el abuso ocurrió dentro de las últimas 72 horas (o, en casos de ser crónico, si el último episodio ocurrió dentro de ese período).

Debido a la variabilidad y los distintos avances en los fármacos disponibles, se sigue la normativa ministerial vigente.

Tratamiento profiláctico para ETS

PATOLOGIA / MEDICACIÓN	DE ELECCIÓN	ALTERNATIVA
Infección gonocócica	Ceftriaxone 125 mg IM en una sola dosis	Cefixime 8mg/kg (máximo 400 mg) una dosis VO o Ciprofloxacina a 30 mg/kg/ día (máximo 500 mg)
Infecciones no gonocócicas (Chlamydia trachomatis)	Azitromicina 20 mg/kg (máximo 1 g) por vía oral una sola dosis	Eritromicina 50 mg/kg/día c/6 hs 10 a 14 días o Doxiciclina 100 mg c/12 hs durante 7 días
Tricomoniasis y vaginosis bacteriana	Metronidazol 15 mg/kg/día VO c/ 8h durante 7 días (máximo 2 g en una sola dosis)	

Anticoncepción de emergencia

- En el paciente que alcanzó su menarca luego de obtener subunidad β negativa
- Antes de las 72 horas
- Levonorgestrel

Condiciones de alta

Se decidirá el alta cuando desde el punto de vista clínico haya superado la necesidad del cuidado y tratamiento intra institucional y además existan las condiciones aceptables de seguridad para el niño, tales como para que se eviten las recidivas.

Por lo tanto, esta medida debe surgir del común acuerdo con ETI, del jefe de la Unidad de internación.

Controles:

- Clínico pediátrico
- Psicológico
- Servicio Social/PPMI
- Infectológico; control clínico y solicitud de laboratorio:

Al mes:

- Hemograma completo
- Hepatograma
- VDRL
- HIV
- Hep B, C y D

A los 3 meses:

- VDRL
- HIV
- Hep B, C y D

A los 6 meses:

- VDRL
- HIV
- Hep B, C y D

Si al control del primer mes estaba recibiendo profilaxis y los resultados son negativos, se suspende.

Sistema legal ante la sospecha de maltrato

Medidas a tomar ante sospecha de maltrato o abuso cuando los involucrados habitan en el mismo domicilio

1. Medida de protección de derecho

Acuerdo entre los padres y otro familiar (ejemplo: abuelos) donde vivirá el paciente.

2. Medida de protección de derecho excepcional

Se separa al paciente de los padres hacia un lugar sustituto (en general un familiar) sin la autorización de los padres (no se llega a un consenso con los progenitores y hay que proteger al paciente).

3. Medidas conexas

La resolución la toma un juez, pero hay que pedirla a través del OAL. Las medidas son: prohibición de acercamiento, exclusión del hogar al agresor, auxilio de la fuerza pública.

Circuito de protección

1. Cuando los involucrados habitan en el mismo domicilio

Se considera una urgencia y el niño debe ser separado inmediatamente del lugar de convivencia.

Podemos considerar como elemento de certeza más importante al relato del paciente.

Debe llamarse seguidamente al OAL para que tome una resolución, en caso de no poder comunicarse el paciente debe ser internado.

También debe ser internado el paciente en el que está indicado el “kits de emergencia” (ETS hasta 72 hs. del abuso, aunque no sea la primera ocasión en que sucede, en el que hay contacto íntimo y hasta 5 días el kits de embarazo).

Es obligatorio hacer la denuncia, en caso de que el familiar a cargo no la realice el médico receptor debe comunicarse a la fiscalía para iniciar una posible acción, en general no estamos totalmente seguros de la situación, no realizamos denuncia, sino que es una notificación (“Noticia incrimini”). En este caso la opción más adecuada es internar al paciente, en esta instancia está protegido, por lo que se puede dar conocimiento a la fiscalía junto con el PPMI.

Al médico receptor no le corresponde hacer la denuncia penal, ya que no puede realizar pericias, solo describimos situación y lesiones en caso de constatarlas. El médico forense es el encargado de evaluar si hay lesiones compatibles con violencia o abuso.

El PPMI actúa ante situaciones violentas dentro del grupo familiar, a diferencia del OAL no atiende urgencias ni casos extra-familiares.

2. Maltrato o abuso institucional

Es obligatorio realizar la denuncia, si el paciente está protegido por los tutores no es necesario contactar al OAL ni internar al paciente.

3. Situaciones de abuso extra-familiar

El familiar a cargo decide si realiza la denuncia penal, siempre y cuando el paciente este protegido por los tutores. Si debe iniciarse el Kits de emergencias para ETS el paciente deberá ser internado.